

Patología Inflamatoria de los Párpados y Vía Lagrimal

- En el contexto del ojo rojo periférico y patología de anexos oculares, existen cuatro entidades principales que se deben reconocer y tratar desde el nivel primario:
- Blefaritis
- Chalazión
- Orzuelo
- Dacriocistitis Aguda

1. Blefaritis

Es la inflamación crónica de los párpados, específicamente del borde libre palpebral.

Clínica:

Diagnóstico: Absolutamente clínico. (Blefaritis anterior compromete visiblemente las pestañas, blefaritis posterior compromete las glándulas de Meibomio más adentro).

Tratamiento:

- Aseo ocular frecuente:** es la piedra angular del tratamiento.
- Tratamiento de la causa subyacente (ej: manejo de la rosácea, lágrimas artificiales si hay ojo seco).

2. Chalazión vs. Orzuelo

Muchas veces son clínica y visualmente indistinguibles en la etapa inflamatoria, pero hay distinciones fisiopatológicas y de curso temporal que inciden en el manejo y la derivación.

TABLA 5.5.1: CARACTERÍSTICA VS ORZUELO		
CARACTERÍSTICA	ORZUELO	CHALAZIÓN
Fisiopatología	Obstrucción e infección aguda del folículo piloso de la pestaña.	Obstrucción de la glándula de Meibomio .
Localización típica	En el borde mismo del párpado (ligado a la pestaña).	Más alejado del borde del párpado (más arriba/adentro).
Inicio de síntomas	Súbito (cuestión de horas, amanece con dolor o hinchado).	Más insidioso, demora algunos días en engrosarse.
Duración esperada	1 a 2 semanas .	Crónico, puede durar 1 a 2 meses .

- **Clínica en ambos:** Aumento de volumen en el párpado con eritema y dolor. - **Tratamiento general para ambos:** - Medida principal: **Masaje en la zona con calor húmedo** de forma localizada (ej: compresa o toalla tibia), de modo de fundir la secreción retenida. - Observación clínica. - **Derivación:** Se derivan al oftalmólogo cuando el cuadro **se absceda** (requiriendo eventualmente un drenaje quirúrgico con incisión) o cuando no responden al tratamiento luego del plazo esperado (1-2 semanas para orzuelo, 1-2 meses para chalazión, para descartar tumores).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En un orzuelo intensamente abscedado y eritematoso, el cuadro se puede complicar con una incipiente **Celulitis Preseptal**. Esto cambia la categorización del cuadro obligando a prescribir antibióticos sistémicos inmediatamente.

3. Dacriocistitis Aguda

Es la inflamación e infección del **saco lagrimal**. Constituye casi invariablemente la complicación aguda de una **Obstrucción de la Vía Lagrimal** preexistente .

Clínica:

- Aumento de volumen delimitado a la zona del saco lagrimal (región **medial o infero-medial** del canto interno del ojo).
- Severo eritema y dolor.
- Epífora persistente (la vía de drenaje de lágrimas está ocluida).
- Signo Patognomónico: Al comprimir levemente el saco inflamado puede refluir **pus por el punto lagrimal**.
- **Evolución y Complicaciones:** Aunque puede autolimitarse, tiene un real riesgo de avanzar y propagarse a algo más grave:
- **Celulitis Preseptal** o, mucho más preocupante, **Celulitis Orbitaria**.
- Absceso francos o incluso Meningitis bacteriana aguda por continuidad venosa en casos pediátricos negligidos.
- **Tratamiento Inmediato:** Su abordaje **es siempre sistémico (vía oral)**, dado que los antibióticos tópicos no logran perfundir y lavar el sistema de drenaje cerrado e inflamado.
- Fármaco de elección empírico: **Amoxicilina/Ácido Clavulánico** (cubre eficientemente al *Staphylococcus aureus* metilino sensible).
- Fármaco en alérgicos: **Clindamicina**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un hombre de cuarenta años consulta por una lesión palpebral derecha de dos semanas de evolución. Es un nódulo duro, indoloro, ubicado en la zona central del párpado superior, lejos del borde palpebral. No hay enrojecimiento local significativo ni dolor espontáneo ni a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para patología inflamatoria de párpados. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La blefaritis es inflamación crónica del borde palpebral, causa más frecuente es rosácea, tratamiento con higiene palpebral con champú de bebé.
- El chalazión es inflamación crónica de la glándula de Meibomio: indoloro, evolución lenta de una a dos semanas, ubicado lejos del borde palpebral.
- El orzuelo es inflamación aguda del folículo piloso de la pestaña: doloroso, instauración en horas, ubicado en el borde mismo del párpado.
- La distinción chalazión versus orzuelo es esencial: chalazión crónico e indoloro lejos del borde; orzuelo agudo y doloroso en el borde.
- La dacriocistitis es inflamación del saco lagrimal, se presenta con dolor y edema en el ángulo interno del ojo, riesgo de celulitis orbitaria.
- El tratamiento de la dacriocistitis no complicada es amoxicilina-ácido clavulánico oral con vigilancia estricta para detectar progresión a celulitis orbitaria.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE PÁRPADOS)

PREGUNTA 1

Un hombre de cuarenta años consulta por una lesión palpebral derecha de dos semanas de evolución. Es un nódulo duro, indoloro, ubicado en la zona central del párpado superior, lejos del borde palpebral. No hay enrojecimiento local significativo ni dolor espontáneo ni a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Orzuelo interno
- B) Chalazión
- C) Dacriocistitis
- D) Blefaritis
- E) Carcinoma de células basales palpebral

PREGUNTA 2

Una mujer de treinta años consulta por dolor en el párpado inferior derecho de doce horas de evolución. Al examen hay una lesión eritematosa, dolorosa, fluctuante, en el borde mismo del párpado inferior, en relación a una pestaña. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A) Antibióticos tópicos y derivación urgente al oftalmólogo
- B) Infiltración con corticoides intralesionales
- C) Calor local y observación, resolución espontánea en una a dos semanas
- D) Amoxicilina-ácido clavulánico oral por diez días
- E) Higiene palpebral con champú de bebé diluido

PREGUNTA 3

Un paciente de cincuenta y cinco años consulta por dolor, enrojecimiento y edema en el ángulo interno del ojo derecho de tres días de evolución. Hay sensibilidad a la presión en esa zona y sale secreción al comprimir el canto interno. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la complicación más grave a vigilar?

- A) Chalazión; complicación más grave es la cicatrización palpebral
- B) Orzuelo; complicación más grave es la queratitis por contacto
- C) Dacriocistitis; complicación más grave es la celulitis orbitaria
- D) Dacriocistitis; complicación más grave es la endoftalmitis
- E) Blefaritis; complicación más grave es la úlcera corneal

RESUMEN: PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE PÁRPADOS

La patología inflamatoria de los párpados incluye varias entidades frecuentes que el médico general debe saber diagnosticar y manejar. La blefaritis es una inflamación crónica del borde palpebral que produce escamas y costras en la base de las pestañas, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. La causa más frecuente en adultos es la rosácea, seguida del estafilococo. El manejo es con higiene palpebral, que consiste en limpieza del borde del párpado con champú de bebé diluido. El chalazión y el orzuelo son dos lesiones nodulares del párpado que se confunden frecuentemente. El chalazión es una inflamación crónica de la glándula de Meibomio, que es la glándula sebácea del párpado. Es una lesión indolora, de evolución lenta, que tarda una a dos semanas en formarse y cuya ubicación característica es lejos del borde palpebral, en la zona tarsal. El orzuelo en cambio es una inflamación aguda del folículo piloso de la pestaña. Se instala en horas, es doloroso, se ubica en el borde mismo del párpado y habitualmente se resuelve en una a dos semanas de manera espontánea. El calor local acelera su resolución. La dacriocistitis es la inflamación del saco lagrimal, que se ubica en el ángulo interno del ojo, en la zona del canto interno. Se presenta con dolor, enrojecimiento y edema en esa zona. El riesgo más importante es la progresión a celulitis orbitaria, que es una complicación grave. El tratamiento es amoxicilina-ácido clavulánico oral en casos no complicados.